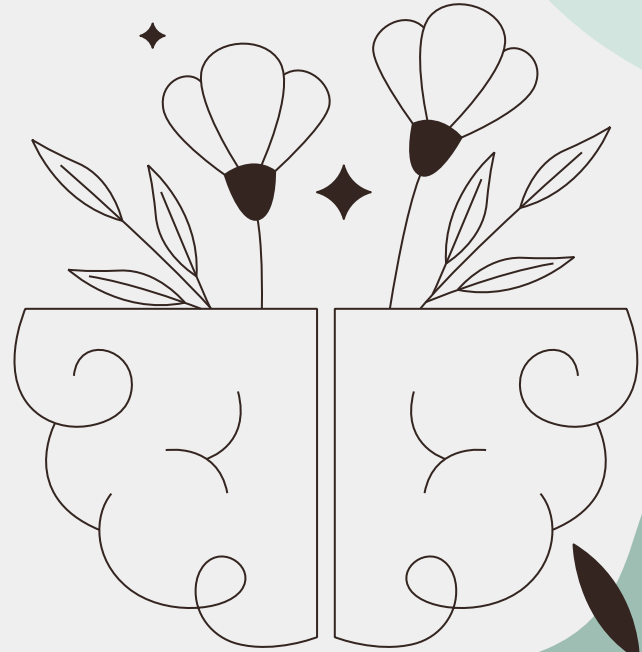




Alteraciones neuropsiquiátricas del adulto y adulto mayor

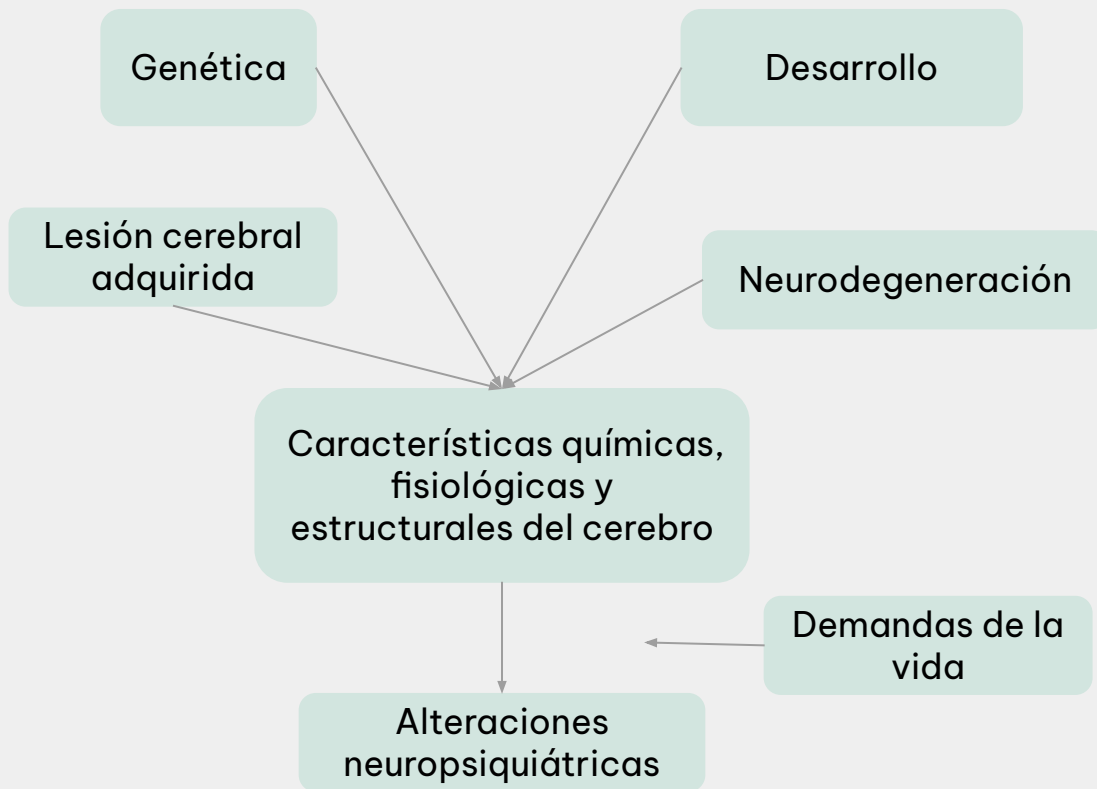


Luisa Fernanda Vidal Agamez



¿Qué son las alteraciones neuropsiquiátricas?

Representan un grupo heterogéneo de síntomas que afectan la percepción, el contenido del pensamiento, el estado de ánimo y el comportamiento (Amer Burhan et al., 2015)



Implicaciones de los SNP



Peores puntuaciones de calidad de vida autoinformadas



Profundo impacto físico y psicológico en los cuidadores tanto formales como informales



Se correlacionan fuertemente con el grado de deterioro funcional y cognitivo



Mayor riesgo de institucionalización y mayores costos de atención médica

1	Hiperactividad	
	Desinhibición Agresividad Irritabilidad Euforia Comportamiento motor aberrante	• Actuar impulsivamente, falta de tacto, vulgaridad • Agresión verbal o física, estallidos de ira • Cambios de humor repentinos, susceptibilidad emocional y reacciones desproporcionadas a situaciones cotidianas • Estado de ánimo anormalmente elevado o inapropiado socialmente • Movimientos repetitivos como ir y venir con la silla de ruedas, caminar sin rumbo
2	Apatía	
	Apatía Trastornos del apetito	• Disminución de las actividades, pérdida de interés en los planes de miembros de la familia u otras personas relevantes, renuencia a iniciar una conversación. • Aumento o disminución en la cantidad de ingesta
3	Psicosis	
	Alucinaciones Delirios Trastornos del sueño	• Ver, oír, oler o sentir cosas que no están presentes • Conspiraciones en su contra, infidelidad, robo • Insomnio, hipersomnia, inversión del ciclo sueño-vigilia, sueño fragmentado y trastorno de conducta del sueño con movimientos oculares rápidos.
4	Síntomas Afectivos	
	Depresión Ansiedad	• Sentimiento de inutilidad y carga para los familiares, tristeza, episodios de llanto, pesimismo e ideas suicidas. • Preocupación excesiva por eventos programados, tensión subjetiva e incapacidad para relajarse

Alteraciones neuropsiquiátricas en adultos

	Prevalencia en Colombia	Neuropsicología
Trastornos de ansiedad	25.3%	Alteraciones en la atención y las funciones ejecutivas (MT, inhibición cognitiva)
Trastornos del estado de ánimo	14.6%	[Depresión mayor]: Afectaciones en funciones ejecutivas (resolución de problemas) atención, VP y memoria visual y verbal
Trastorno por uso de sustancias	9.6%	[Alcohol]: Afectaciones en atención, funciones ejecutivas (MT) y memoria episódica y semántica

(Gustavson et al., 2018)

Perfil cognitivo en trastorno depresivo mayor

Table 3

Neurocognitive scores of the MCCB (T scores) in depression patients ($n = 24-33$) and healthy controls ($n = 33$)

	Depression	Controls	F	η^2
Speed of Processing	45.4 (8.5)	54.6 (4.9)	28.51 ***	.31
TMT-A	45.2 (11.5)	54.8 (4.6)	20.07 ***	.24
BACS	44.4 (9.2)	55.6 (7.4)	29.14 ***	.31
Fluency	46.7 (11.1)	53.3 (7.5)	8.11 **	.11
Attention/Vigilance (CPT-IP)	46.9 (10.3) ($n = 24$)	52.3 (9.3)	4.29 *	.07
Working Memory	46.9 (8.8)	53.1 (7.0)	10.24 **	.14
SS-WMS	46.2 (10.1)	53.8 (8.4)	11.20 ***	.15
LNS	47.6 (11.5)	52.4 (7.6)	4.04 *	.06
Verbal Learning (HVL-R)	47.2 (10.2)	54.8 (9.1)	5.47 *	.08
Visual Learning (BVM-R)	47.1 (11.2)	52.9 (7.8)	6.18 *	.09
Reasoning/Problem Solving (Mazes)	45.6 (11.1)	54.4 (6.2)	15.73 ***	.20
Social Cognition (MSCEIT)	46.9 (10.3) ($n = 30$)	53.4 (9.2)	8.83 ***	.13
Composite Score	48.4 (5.4) ($n = 24$)	53.6 (4.2)	16.30 ***	.23

Neurocognitive scores in mean (SD). F: Significance test of group differences. ***: $p < .001$, **: $p < .01$, *: $p < .05$. η^2 : effect size

En comparación con el grupo de control, el grupo con depresión obtuvo resultados significativamente peores en todas las pruebas neurocognitivas.

Los efectos fueron mayores en las evaluaciones de **VP y razonamiento/solución de problemas**, en las que el grupo de pacientes obtuvo resultados entre 1,5 y 2,0 DE por debajo de la media del grupo de control.

(Mohn & Bjørn Rishovd Rund, 2016)

Perfil neurocognitivo en Trastorno de Ansiedad Generalizada

	Diferencias significativas en TAG frente a control		Sin diferencias significativas en TAG frente a control
Atención compleja	Déficit de atención selectiva [9-11]		–
	Sesgo atencional hacia estímulos amenazantes [12,13]		Sin sesgo atencional [14,15]
	Distracción con estímulos amenazantes [15-18]		–
Memoria	Déficit de memoria a corto plazo [19], déficit de memoria diferida visual (TAGf) [11]		–
	Sesgo de memoria a favor de palabras relacionadas con ansiedad [20]		Sin sesgo de memoria en tareas de reconocimiento [21] o aprendizaje incidental [22]
Funciones visuoperceptivas	–		Sin diferencias con los controles [11,23]
Funciones ejecutivas	Déficit de flexibilidad cognitiva (WCST) [11,24]	Mayor flexibilidad cognitiva en condiciones de estrés [9]	Sin diferencias con los controles (WCST) [25]
	Dificultad de aprendizaje por error [25]	Mayor sensibilidad al aprendizaje por error [26]	–
	Déficit de predicción del error en la toma de decisiones [27,28]		–
	Déficit de memoria de trabajo verbal (n-back) [29-31] y visual (figura compleja de Rey) [9]; empeora con distractores amenazantes [32-34]		Sin diferencias con controles en algunas tareas de memoria de trabajo verbal (dígitos) o visual (cubos de Corsi) [11]
	–		Sin diferencias con los controles en las tareas de inhibición de conducta [8,35]
	Déficit de inhibición cognitiva en el test de Stroop [8], en el test de Stroop emocional [22,36-38] y en las tareas de conflicto emocional [17,39]		Sin diferencias con los controles en las tareas no verbales de inhibición cognitiva [35]. Sin diferencias con los controles en el test de Stroop emocional [9]

(Langarita-Llorente et al., 2019)

Alteraciones neuropsiquiátricas: daño cerebral adquirido

Table 3. Incidence of neuropsychiatric disturbances in the poststroke population

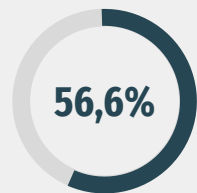
Symptom	Healthy controls 95 th percentile	No. of patients >95 th percentile	% Patients >95 th percentile
Delusion	0	2	1.6
Hallucination	0	1	0.8
Agitation	1	35	28.2
Depression	1	76	61.3
Anxiety	2	28	22.6
Euphoria	0	9	7.2
Apathy	2	33	26.6
Disinhibition	0	12	9.7
Irritability	2	41	33
Aberrant motor behavior	0	13	10.5
Nighttime disturbances	0	22	17.7
Appetite/eating disturbances	1	41	33.1

ACV (Angelelli et al., 2004)

- El síntoma neuropsiquiátrico más frecuente fue la depresión, seguido de irritabilidad, trastornos del apetito/la alimentación, agitación, apatía, ansiedad y trastornos nocturnos.
- Los comportamientos menos frecuentes fueron los delirios y las alucinaciones.

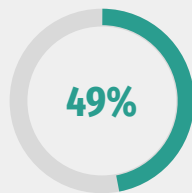
Alteraciones neuropsiquiátricas: daño cerebral adquirido

TCE (Beatriz Castaño Monsalve et al., 2012)



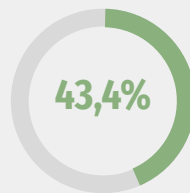
Irritabilidad/labilidad

Enfados desproporcionados, cambios bruscos de humor



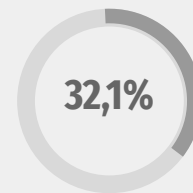
Apatía

Disminución de la iniciativa, atenuación de la expresión de emociones, indiferencia



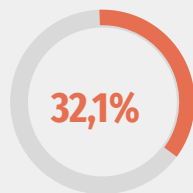
Depresión

Tristeza, sentimiento de inutilidad, episodios de llanto



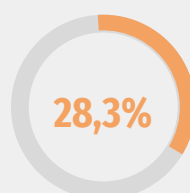
Deshinibición

De tipo verbal o motora



Trastornos de alimentación

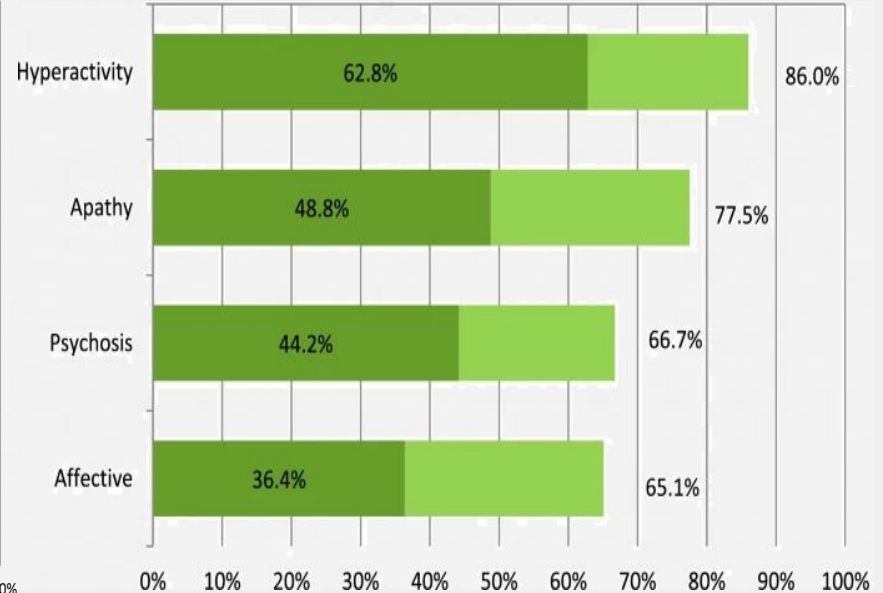
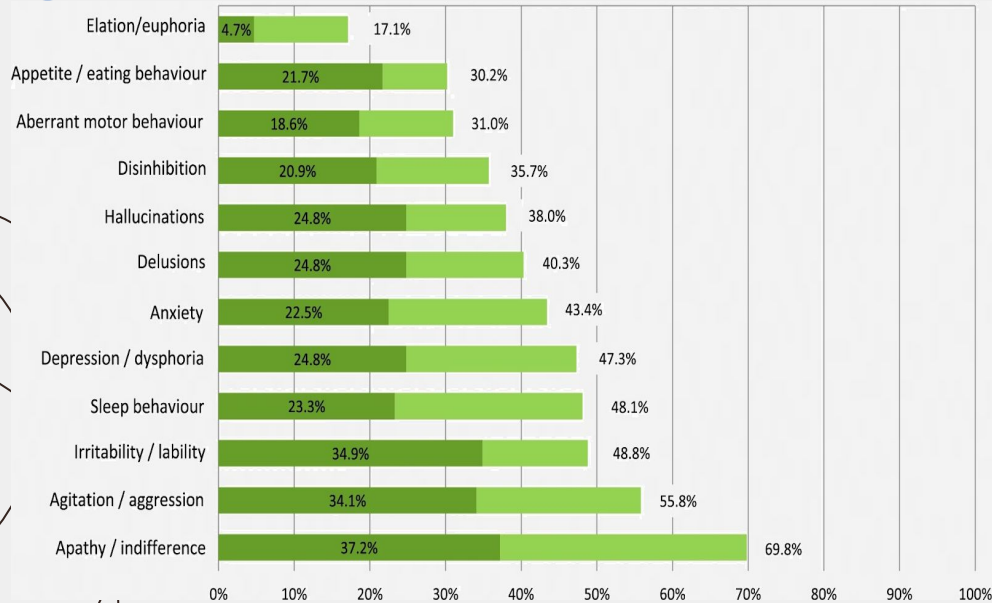
Cambios en la velocidad o en la forma de tomar los alimentos, aumento o disminución en la ingesta o cambios de gustos.



Ansiedad

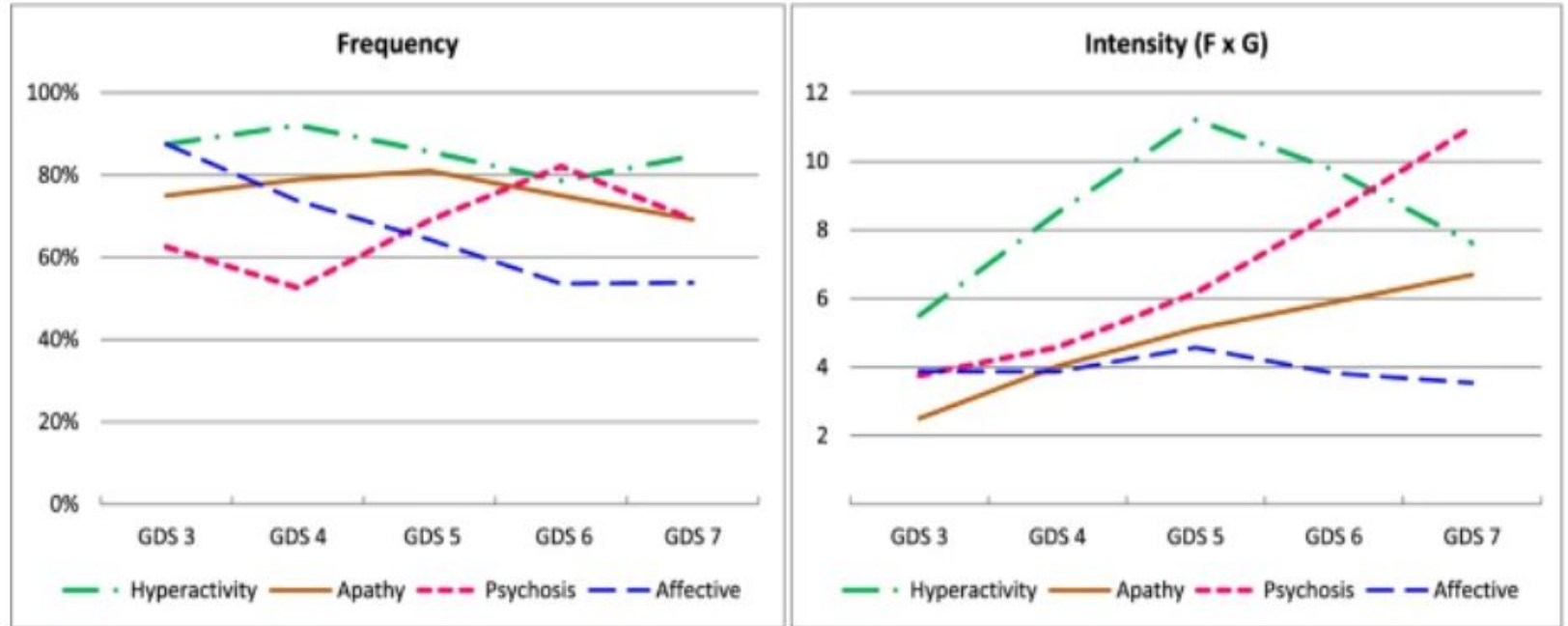
Preocupación excesiva

Alteraciones neuropsiquiátricas en TCM



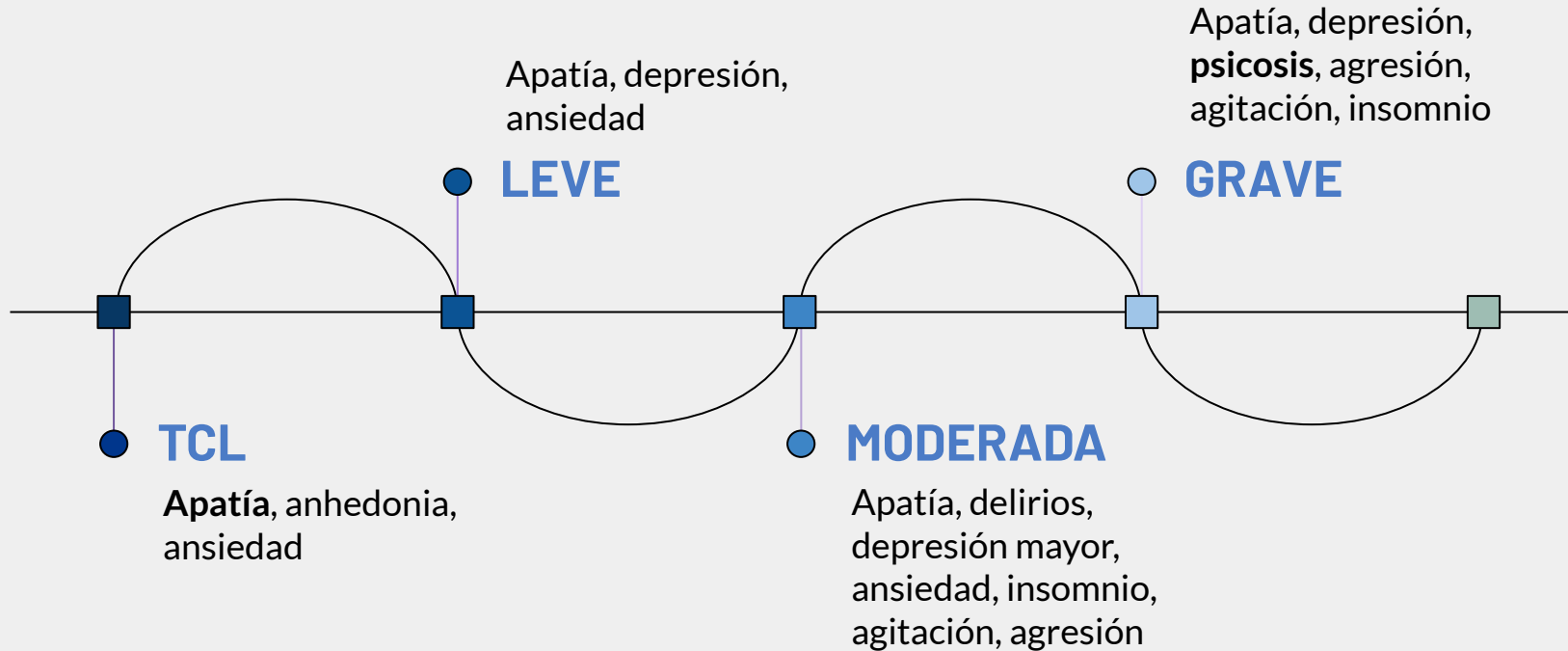
*Las barras claras representan la prevalencia de síntomas totales, y las barras oscuras la prevalencia de síntomas clínicamente significativos (aquellos con una frecuencia de NPI por puntuación de gravedad ≥ 4) (García-Martín et al., 2022)

Frecuencia e intensidad de los síntomas neuropsiquiátricos en función de la progresión de la demencia (estadio GDS) agrupados por subsíndromes



(García-Martín et al., 2022)

Alteraciones neuropsiquiátricas en la enfermedad de Alzheimer



(Pless et al., 2023; Forugh Salimi Dafsari & Jessen, 2020)

Depresión

- Tres etapas diferentes: puede ser un factor de riesgo, puede ser un signo temprano de cambios neurodegenerativos o puede aparecer en un estadio avanzado
- Es el síntoma neuropsiquiátrico predominante del DCL amnésico.

Apatía

- La apatía ha sido un predictor de progresión de DCL amnésico a EA
- Puede surgir temprano y permanecer a lo largo de la progresión en la EA
- La presencia de apatía refleja disfunción corticosubcortical con desconexión del cíngulo anterior y alteraciones en el funcionamiento de las vías dopaminérgica mesolímbica y mesocortical

Agitación/ agresión

- Se manifiesta en inquietud, intranquilidad excesiva, abusos verbales, gritos, así como actividades físicas más violentas como golpear y lanzar objetos al cuidador
- Las causas pueden estar relacionadas con necesidades básicas que no se pueden comunicar bien, como la sed, el hambre y el dolor.

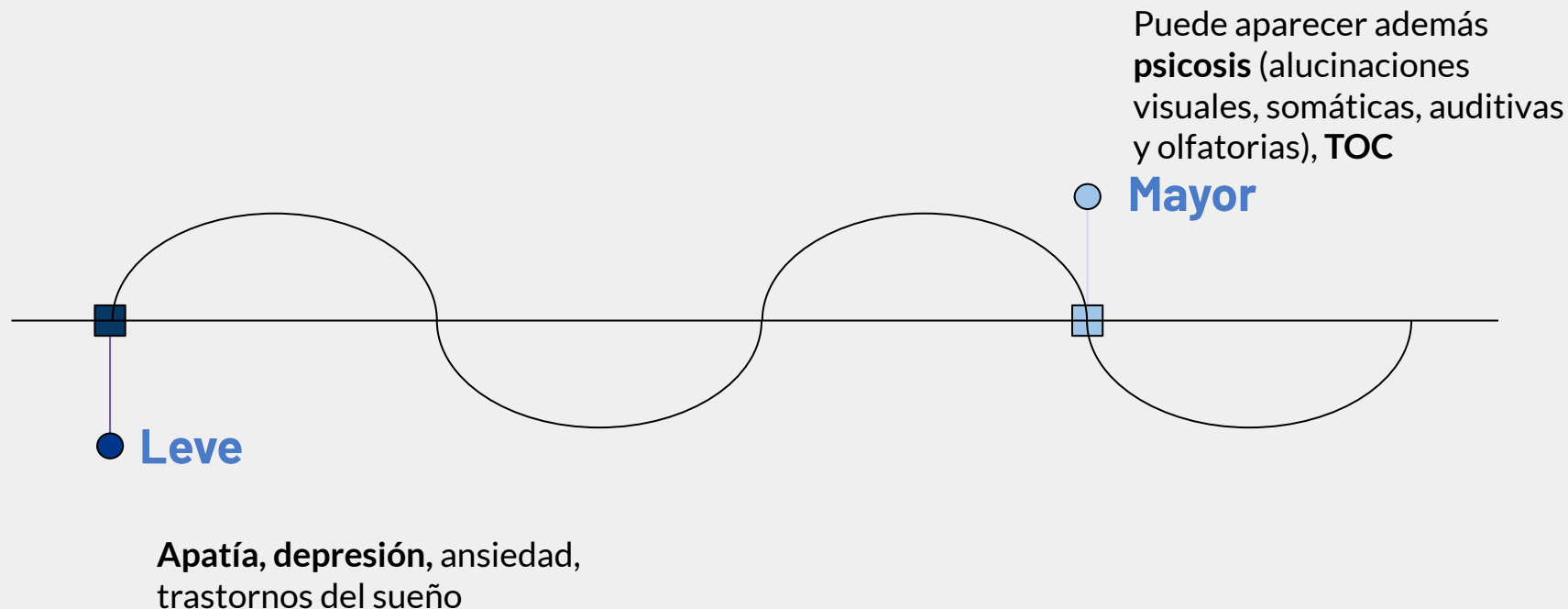
Psicosis

- La psicosis afecta principalmente a individuos en fases avanzadas de la enfermedad
- Delirios comunes sobre robo, infidelidad, persecución, abandono
- Las alucinaciones pueden ocurrir en cualquier modalidad sensorial, siendo más comunes las visuales

Trastornos del sueño

- Son más comunes en estadios avanzados
- El insomnio y los cambios en el ciclo sueño-vigilia son las alteraciones más comunes.

Alteraciones neuropsiquiátricas en la enfermedad de Parkinson



(Álvaro Javier Cruz-Gómez y González-Rosa, 2022; González-Usigli et al., 2023)

Depresión

- Pueden preceder a la aparición de la enfermedad y constituir un factor de riesgo
- Pacientes con EP experimentan menos sentimientos de culpa y autorreproche y más irritabilidad, tristeza y preocupación por su estado de salud en comparación con depresión primaria
- Las fluctuaciones del estado de ánimo pueden ir acompañadas de fluctuaciones motoras "on-off"
- Base biológica: daños en transmisión monoaminérgica

Apatía

- Patología producida por un daño del sistema de autoactivación que se produce tras las lesiones de los ganglios basales.

Ansiedad

- Pueden asociarse a fluctuaciones "on-off" relacionadas con la duración del efecto del tratamiento dopaminérgico, con una acentuación particular de los síntomas durante las fases "off"

TOC

- Afectación de los circuitos frontoestriatales
- Mayor frecuencia en pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, especialmente en pacientes con inicio clínico motor en el lado izquierdo.

Psicosis

- Los síntomas psicóticos pueden estar asociados directamente a la enfermedad, al tratamiento farmacológico o a ambos.
- Las alucinaciones son predominantemente visuales y suelen aparecer en la segunda mitad del curso de la enfermedad.
- Los delirios más frecuentes son de tipo persecutorio o de celos.

Alteraciones neuropsiquiátricas en la DFT (variante conductual)

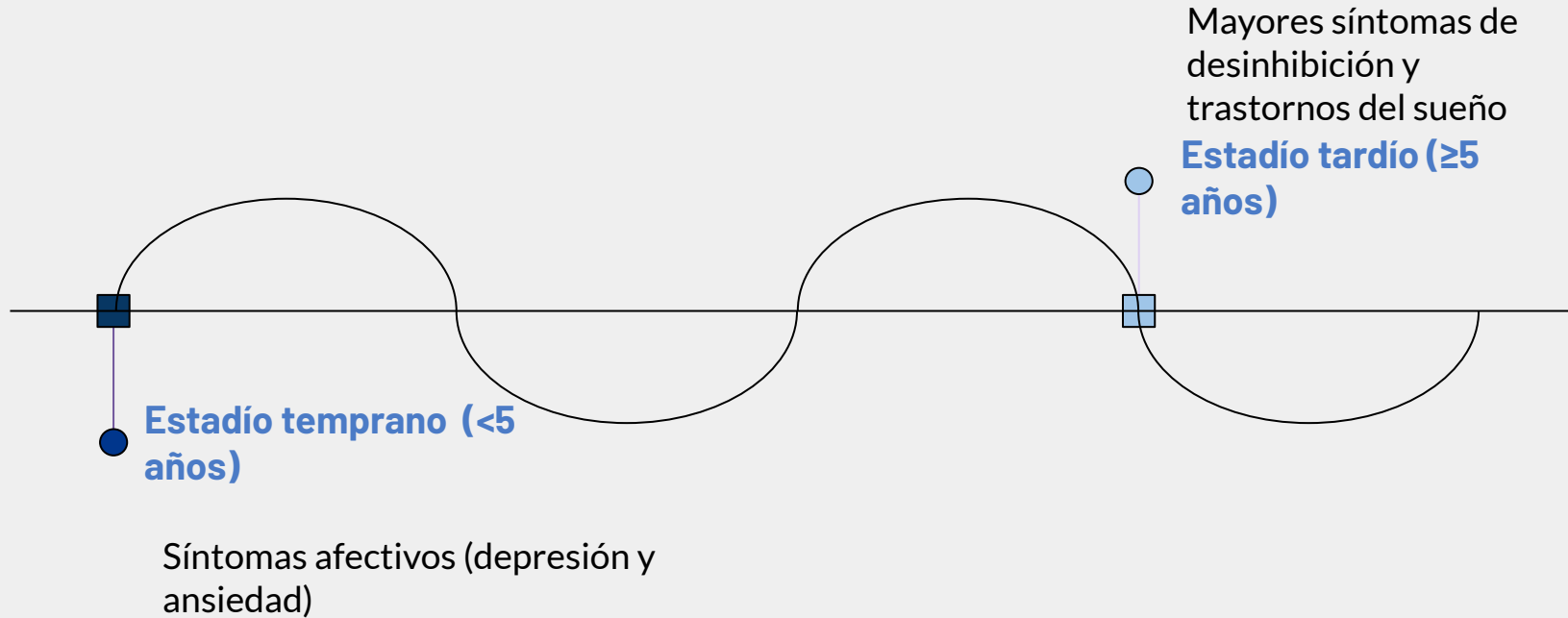
Pueden aparecer además alucinaciones y delirios con una prevalencia baja

Mayor

Leve

Deshinibición, apatía, irritabilidad, pérdida de empatía, hiperoralidad y cambios alimenticios

Alteraciones neuropsiquiátricas en la DFT (APP)



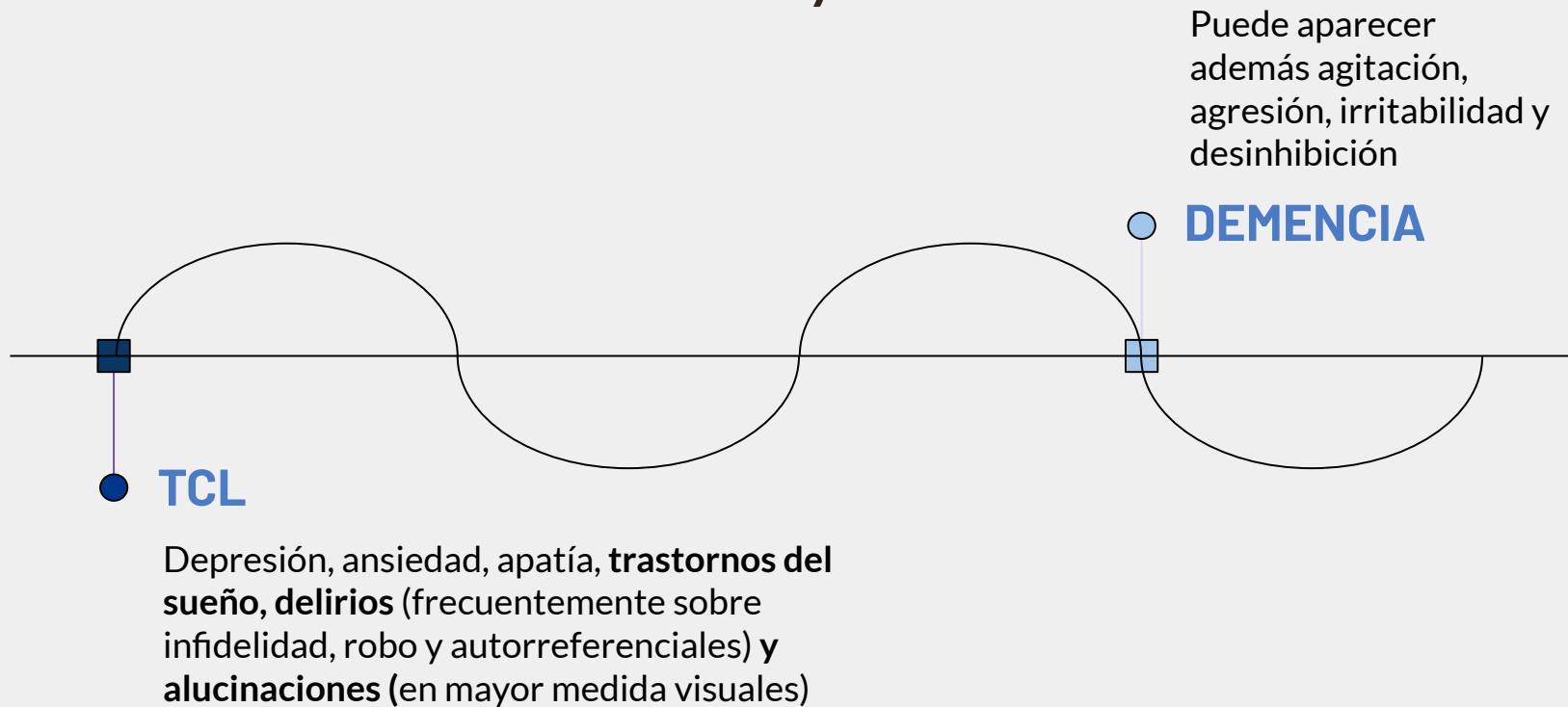
Depresión y apatía

- En la DFTvc se caracteriza por pérdida de interés, falta de motivación, baja energía y problemas de concentración
- La apatía en la DFTvc no despierta sentimientos de disforia ni sufrimiento psíquico
- Los pacientes con PPA en estadio temprano tendían a presentar en mayor medida síntomas del estado de ánimo

Psicosis

- Las alucinaciones y delirios están ausentes en la APP.
- Los síntomas psicóticos se observan en el 13-14% de los casos de DFTvc.

Alteraciones neuropsiquiátricas en demencia por cuerpos de Lewy



(Wright et al, 2023; Fernanda, 2017)

Alucinaciones y delirios

- Las alucinaciones visuales hacen parte de los criterios diagnósticos, se caracterizan por ser imágenes recurrentes de animales, insectos, personas u objetos
- Los delirios son más prevalentes que en otros tipos de demencia y se presentan en cualquier estadio de la enfermedad. Son de contenido paranoide (infidelidad, robo, referencialidad)

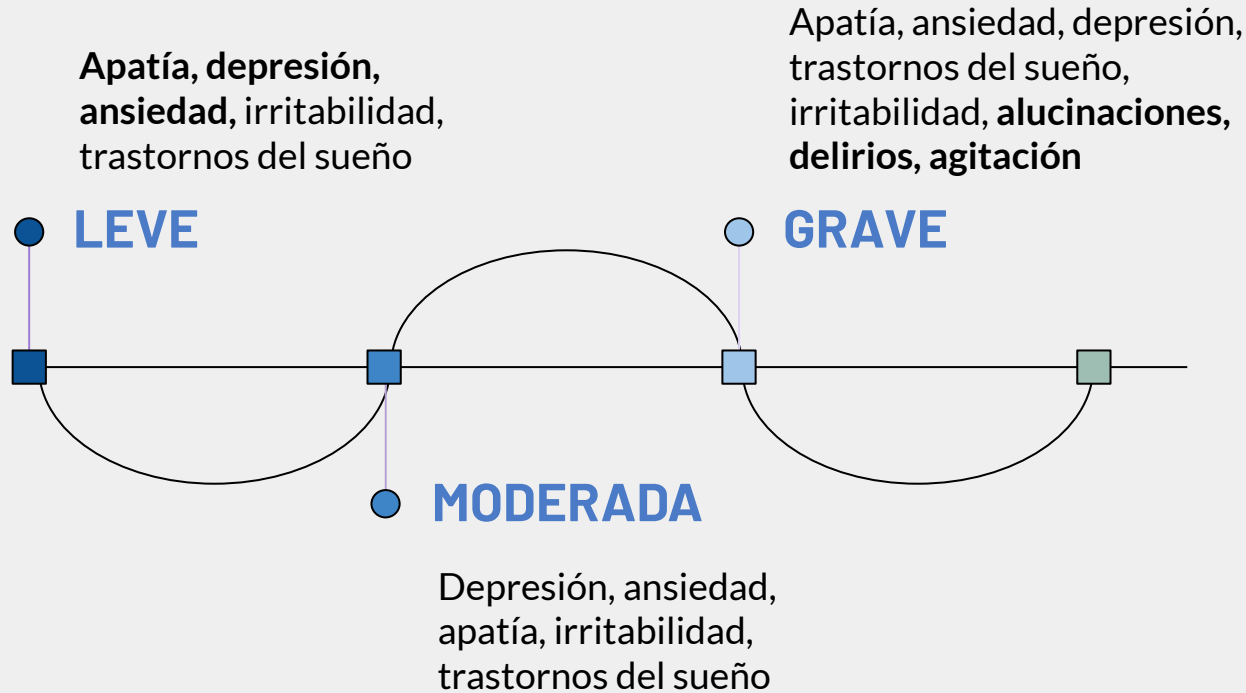
Depresión

- Se presenta de forma precoz en la enfermedad y es más frecuente, persistente y de más difícil manejo que en la DA
- Se produce por la acumulación de cuerpos de Lewy en el rafe dorsal, lo que disminuye la concentración de serotonina en el estriado y la corteza

Trastornos del sueño

- El más frecuente es el trastorno conductual del sueño de movimientos oculares rápidos, que suele preceder en varios años al inicio de la enfermedad

Alteraciones neuropsiquiátricas en demencia vascular



Apatía

- La apatía fue el síntoma neuropsiquiátrico más prevalente
- Se relaciona con el daño de la red de sustancia blanca en la lesión de vasos pequeños
- Una mayor apatía basal, así como el aumento de la apatía a lo largo del tiempo, estaban asociados con un mayor riesgo de demencia

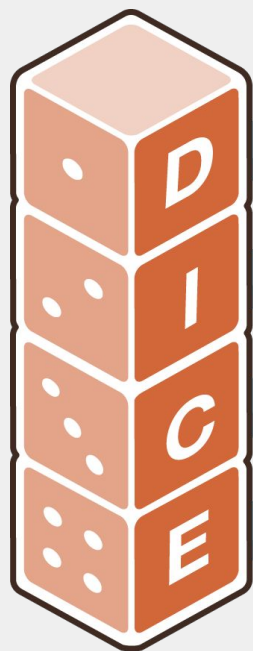
Depresión

- Se ha reportado mayor frecuencia de síntomas depresivos en la DV que en la EA con una diferencia significativa.
- Cursa con mayor anhedonia, aislamiento social y discapacidad funcional que la depresión no vascular

Psicosis

- En la DV de grandes vasos los delirios y las alucinaciones aumentaron en asociación con el empeoramiento de la demencia.
- En la DV de vasos pequeños las alucinaciones y delirios aumentaron en frecuencia de leve a moderada y disminuyeron en la etapa grave.

Estrategia DICE para el abordaje de síntomas neuropsiquiátricos en demencia



DESCRIBE

Descripción específica de la conducta, el contexto en que se presenta, el aspecto más problemático, la reacción del cuidador

INVESTIGATE

Consideraciones del paciente, del cuidador y del ambiente

CREATE

Crear y aplicar un plan de tratamiento acorde con hallazgos del paciente, el cuidador y la familia

EVALUATE

Se sugieren intervenciones dirigidas al dolor, la educación del cuidador, la comunicación, las preferencias personales y el entorno.

Referencias

Álvaro Javier Cruz-Gómez, & González-Rosa, J. J. (2022). Neuropsychiatric Symptoms in Clinically Defined Parkinson's Disease: An Updated Review of Literature. *Behavioural Neurology*, 2022, 1–16. <https://doi.org/10.1155/2022/1213393>

Ahuanca, L.F. (2017). Más allá del deterioro cognitivo: síntomas neuropsiquiátricos en demencias neurodegenerativas. *Revista Colombiana de Psiquiatría*. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2017.05.006>

Beatriz Castaño Monsalve, Montserrat Bernabeu Guitart, López, R., Antoni Bulbena Vilasar, & José Ignacio Quemada. (2012). Perfil psicopatológico de pacientes con traumatismo craneoencefálico evaluados mediante el Inventario Neuropsiquiátrico. *Revista de Psiquiatría Y Salud Mental*, 5(3), 160–166. <https://doi.org/10.1016/j.rpsm.2012.02.004>

Burhan, A. M., Marlatt, N. M., Palaniyappan, L., Udunna Anazodo, & Prato, F. S. (2015). Role of Hybrid Brain Imaging in Neuropsychiatric Disorders. *Diagnostics*, 5(4), 577–614. <https://doi.org/10.3390/diagnostics5040577>

Colimón, N., Palau, M., & Mendoza Bermúdez, Constanza. (2023). Alteraciones neuropsiquiátricas en demencia vascular. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 34(2), 305–314. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502005000200010

Ferro, J. M., Caeiro, L., & Figueira, M. L. (2016). Neuropsychiatric sequelae of stroke. *Nature Reviews. Neurology*, 12(5), 269–280. <https://doi.org/10.1038/nrneurol.2016.46>

Forugh Salimi Dafsari, & Jessen, F. (2020). Depression—an underrecognized target for prevention of dementia in Alzheimer's disease. *Translational Psychiatry*, 10(1). <https://doi.org/10.1038/s41398-020-0839-1>

García-Martín, V., Canto, M., Ariza-Cardiel, G., Rosalía Delgado-Puebla, García-Domingo, P., Hernández-Melo, E., López, J., & del-Cura-González, I. (2022). Neuropsychiatric symptoms and subsyndromes in patients with different stages of dementia in primary care follow-up (NeDEM project): a cross-sectional study. *BMC Geriatrics*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12877-022-02762-9>

González-Usigli, H.A.; Ortiz, G.G.; Charles-Niño, C.; Mireles-Ramírez, M.A.; Pacheco Moisés, F.P.; Torres-Mendoza, B.M.d.G.; Hernández-Cruz, J.d.J.; Delgado-Lara, D.L.d.C.; Ramírez-Jirano, L.J. Neurocognitive Psychiatric and Neuropsychological Alterations in Parkinson's Disease: A Basic and Clinical Approach. *Brain Sci.* 2023, 13, 508. <https://doi.org/10.3390/brainsci13030508J>

Referencias

- Gustavson, K., Ann Kristin Knudsen, Ragnar Nesvåg, Gun Peggy Knudsen, Stein Emil Vollset, & Reichborn-Kjennerud, T. (2018). Prevalence and stability of mental disorders among young adults: findings from a longitudinal study. *BMC Psychiatry*, 18(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-018-1647-5>
- Jin, Y., Zhang, H., Gao, Y.-Z., Shu, M., Xu, Y., Xi, L., Zhang, S., Zou, C.-Y., Cao, J., & Xiong, R.-H. (2015). Neuropsychiatric symptoms in patients with vascular dementia in mainland China. *Translational Neuroscience*, 6(1), 157–161. <https://doi.org/10.1515/tnsci-2015-0015>
- Jung Yun Jang, Ho, J. K., Blanken, A. E., Dutt, S., Nation, D. A., & Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. (2020). Affective Neuropsychiatric Symptoms as Early Signs of Dementia Risk in Older Adults. *Journal of Alzheimer's Disease*, 77(3), 1195–1207. <https://doi.org/10.3233/jad-200190>
- Kohnen, R., Jan, Reinier Akkermans, Gerritsen, D. L., & Raymond T.C.M. Koopmans. (2020). The Prevalence and Determinants of Neuropsychiatric Symptoms in People With Acquired Brain Injury in Nursing Homes. *Journal of the American Medical Directors Association*, 21(11), 1643–1650. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.07.017>
- Mohn, C., & Bjørn Rishovd Rund. (2016). Neurocognitive profile in major depressive disorders: relationship to symptom level and subjective memory complaints. *BMC Psychiatry*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s12888-016-0815-8>
- Pless, A., Ware, D., Shalini Saggu, Rehman, H., Morgan, J. C., & Wang, Q. (2023). Understanding neuropsychiatric symptoms in Alzheimer's disease: challenges and advances in diagnosis and treatment. *Frontiers in Neuroscience*, 17. <https://doi.org/10.3389/fnins.2023.1263771>
- Torregrossa, W., Raciti, L., Rifichi, C., Rizzo, G., Raciti, G., Casella, C., Naro, A., & Rocco Salvatore Calabrò. (2023). Behavioral and Psychiatric Symptoms in Patients with Severe Traumatic Brain Injury: A Comprehensive Overview. *Biomedicines*, 11(5), 1449–1449. <https://doi.org/10.3390/biomedicines11051449>
- Wright, L., Donaghy, P. C., Burn, D. J., Taylor, J., O'Brien, J. T., Yarnall, A. J., Matthews, F. E., Firbank, M., Thomas, A., & Lawson, R. A. (2023). Predicting cognitive decline using neuropsychiatric symptoms in prodromal Lewy body dementia: A longitudinal study. *Parkinsonism & Related Disorders*, 113, 105762–105762. <https://doi.org/10.1016/j.parkreldis.2023.105762>